TÓM TẮT ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

1. Thông tin thuốc

1.1. Tên thuốc
VAXIGRIP

1.2. Nồng độ/hàm lượng
Trong một liều 0,5 ml
Virus Cúm gồm các chủng sau* (vắc-xin dạng mảnh, bất hoạt):

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09- sử dụng chủng tương đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-238)..... 15 mcg HA**
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)- sử dụng chủng tương đương (A/Darwin/9/2021, IVR-228)..... 15 mcg HA**
- B/Austria/1359417/2021- sử dụng chủng tương đương (B/Michigan/01/2021, wild type)..... 15 mcg HA**

*cấy trên trứng gà có phôi, có nguồn gốc từ đàn gà khỏe mạnh
**ngưng kết tố hồng cầu
Vắc-xin này tuân theo các khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O.) và Liên minh Châu Âu cho mùa Cúm 2023/2024 vùng Bắc Bán Cầu**.**

1.3. Dạng bào chế
Hỗn dịch tiêm.

2. Định tính và định lượng

2.1. Công bố về định tính
Trong một liều 0,5 ml Virus Cúm gồm các chủng sau* (vắc-xin dạng mảnh, bất hoạt):
A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09- sử dụng chủng tương đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-238)
A/Darwin/9/2021 (H3N2)- sử dụng chủng tương đương (A/Darwin/9/2021, IVR-228)
B/Austria/1359417/2021- sử dụng chủng tương đương (B/Michigan/01/2021, wild type)

2.2. Công bố về định lượng
Thành phần hoạt chất: Trong một liều 0,5 ml
Virus Cúm gồm các chủng sau* (vắc-xin dạng mảnh, bất hoạt):

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09- sử dụng chủng tương đương (A/Victoria/4897/2022, IVR-238)..... 15 mcg HA**
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)- sử dụng chủng tương đương (A/Darwin/9/2021, IVR-228)..... 15 mcg HA**
- B/Austria/1359417/2021- sử dụng chủng tương đương (B/Michigan/01/2021, wild type)..... 15 mcg HA**

*cấy trên trứng gà có phôi, có nguồn gốc từ đàn gà khỏe mạnh

**ngưng kết tố hồng cầu
Vắc-xin này tuân theo các khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (W.H.O.) và Liên minh Châu Âu cho mùa Cúm 2023/2024 vùng Bắc Bán Cầu**.**

3. Dạng sản phẩm:
Hỗn dịch tiêm. Sau khi lắc nhẹ, VAXIGRIP là một chất lỏng màu trắng đục.

4. Các đặc tính lâm sàng
4.1. Chỉ định điều trị
Vắc xin VAXIGRIP được chỉ định để phòng ngừa bệnh Cúm mùa do vi-rút cúm thuộc các chủng cúm A và B có trong thành phần của vắc-xin cho:
- Tiêm chủng chủ động ở người lớn, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.
Bảo vệ thụ động ở trẻ sơ sinh từ lúc mới sinh đến dưới 6 tháng tuổi sau khi tiêm vắc-xin cho phụ nữ mang thai.
Việc sử dụng Vắc xin VAXIGRIP nên được sử dụng theo các khuyến cáo chính thức.

4.2. Liều lượng và cách dùng
Nên thực hiện tiêm vắc-xin phòng cúm hàng năm dựa trên thời gian miễn dịch do vắc-xin cung cấp và do các chủng vi-rút cúm lưu hành thay đổi theo từng năm.

Liều dùng
Người lớn: một liều 0,5 ml.
Trẻ em
- Trẻ em từ 6 tháng đến 17 tuổi: một liều 0,5 ml.
Các trẻ dưới 9 tuổi trước đây chưa được tiêm ngừa Cúm, phải tiêm liều thứ hai cách liều đầu tiên ít nhất là 4 tuần.
- Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi: chưa xác định được độ an toàn và tính hiệu lực của VAXIGRIP khi dùng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Hiện không có dữ liệu.
Về bảo vệ thụ động: một liều 0,5 ml dùng cho phụ nữ mang thai có thể bảo vệ trẻ sơ sinh từ lúc mới sinh đến dưới 6 tháng tuổi; tuy nhiên, không phải tất cả những trẻ sơ sinh này sẽ được bảo vệ (xem mục "ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC").

Cách dùng
Đường dùng ưu tiên cho vắc-xin này là tiêm bắp, mặc dù cũng có thể được tiêm dưới da.
Người lớn và trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên: vị trí thích hợp để tiêm bắp là cơ Delta.
Trẻ từ 6 tháng tuổi đến 35 tháng tuổi: vị trí thích hợp để tiêm bắp là mặt trước-bên của đùi (hay ở cơ Delta nếu khối cơ thích hợp để tiêm bắp).

Thận trọng trước khi thao tác hay dùng thuốc
Hướng dẫn về chuẩn bị thuốc trước khi dùng:
Phải để vắc-xin về nhiệt độ phòng trước khi dùng.
Lắc trước khi dùng. Quan sát hình thức cảm quan bằng mắt thường trước khi dùng.

Không được dùng vắc-xin khi thấy có phần tử lạ trong hỗn dịch.
Các sản phẩm không còn sử dụng hay thải bỏ cần phải được xử lý theo qui định hiện hành.

4.3. Chống chỉ định:
Quá mẫn cảm với các hoạt chất, với bất kỳ tá dược liệt kê trong mục "THÀNH PHẦN" hay với bất kỳ chất nào có thể có trong thành phần dù với một lượng rất nhỏ còn sót lại (vết) như trứng (ovalbumin, protein của gà), neomycin, formaldehyde và octoxinol-9.
Phải hoãn việc tiêm vắc-xin khi bị bệnh có sốt vừa hay sốt cao hay bị bệnh cấp tính.

4.4. Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng
Truy xuất nguồn gốc:
Để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thuốc sinh học, tên và số lô của sản phẩm được sử dụng phải được ghi lại rõ ràng.
Như khi dùng các vắc-xin bằng đường tiêm khác, luôn phải chuẩn bị sẵn đầy đủ phương tiện điều trị y tế thích hợp và theo dõi tình hình sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin trong trường hợp xảy ra phản ứng phản vệ sau khi tiêm vắc xin.
Không được tiêm VAXIGRIP vào mạch máu trong bất kỳ trường hợp nào.
Như khi dùng các vắc-xin khác bằng đường tiêm bắp, phải tiêm một cách thận trọng ở người bị giảm tiểu cầu hay bị rối loạn chảy máu vì những người này có thể bị chảy máu khi tiêm bắp.
Ngất (bất tỉnh) có thể xảy ra do các phản ứng tâm lý với kim tiêm lúc trước tiêm hoặc sau tiêm. Cần có sẵn các quy trình để phòng ngừa thương tích do té ngã và xử trí phản ứng ngất.
Mục đích của VAXIGRIP là bảo vệ chống lại những chủng vi-rút điều chế nên vắc-xin.
Như các vắc-xin khác, tiêm chủng với VAXIGRIP có thể không bảo vệ được tất cả người được tiêm.
Về bảo vệ thụ động, không phải tất cả trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi sinh ra từ người mẹ đã tiêm chủng trong thai kỳ sẽ được bảo vệ (xem mục "ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC").
Đáp ứng miễn dịch ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải có thể không đầy đủ.
Tá dược:
Mỗi liều VAXIGRIP có chứa ít hơn 1 mmol kali (39 mg) và natri (23 mg), có thể xem như "không chứa kali và không chứa natri"

4.5. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:
Tương tác với các thuốc hoặc vắc-xin khác
VAXIGRIP có thể tiêm cùng lúc với các vắc-xin khác. Trong trường hợp dùng đồng thời, nên tiêm ở các vị trí khác nhau và sử dụng ống tiêm riêng.
Đáp ứng miễn dịch có thể giảm khi tiêm cho bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch.

4.6. Trường hợp có thai và cho con bú
Phụ nữ có thai:
Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các biến chứng cúm cao, bao gồm chuyển dạ và sinh non, nhập viện và tử vong; phụ nữ mang thai nên được chủng ngừa cúm.
Có thể tiêm VAXIGRIP vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Dữ liệu về tính an toàn khi dùng vắc-xin này vào 3 tháng giữa hay 3 tháng cuối thai kỳ nhiều hơn dữ liệu về tính an toàn khi dùng vắc-xin này trong 3 tháng đầu thai kỳ. Dữ liệu từ việc sử dụng vắc-xin cúm bất hoạt trên toàn thế giới, bao gồm VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA (vắc-xin cúm tứ giá bất hoạt), không chỉ ra bất kỳ kết quả bất lợi nào của thai nhi hoặc người mẹ do vắc-xin.
Kết quả này thống nhất với dữ liệu từ một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện với VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA trên phụ nữ trong ba tháng giữa hoặc cuối thai kỳ (116 trường hợp mang thai và 119 trẻ mới sinh đối với VAXIGRIP, 230 trường hợp mang thai và 231 trẻ mới sinh cho VAXIGRIP TETRA).
Dữ liệu từ bốn nghiên cứu lâm sàng được thực hiện với VAXIGRIP dùng cho phụ nữ phụ nữ trong ba tháng giữa hoặc cuối thai kỳ (hơn 5.000 trường hợp mang thai và hơn 5.000 trẻ mới sinh, theo dõi đến khoảng 6 tháng sau sinh) không chỉ ra bất kỳ kết quả bất lợi nào trên thai nhi, trẻ mới sinh, trẻ sơ sinh hoặc người mẹ do vắc-xin.
Trong các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở Nam Phi và Nepal, không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm VAXIGRIP và nhóm giả dược liên quan đến kết cục của thai nhi, trẻ mới sinh, trẻ sơ sinh hoặc người mẹ (bao gồm sẩy thai, thai chết lưu, sinh non, nhẹ cân).
Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Mali, không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm VAXIGRIP và vắc-xin đối chứng (vắc-xin liên hợp não mô cầu tứ giá) liên quan đến tỷ lệ sinh non, tỷ lệ thai chết lưu hoặc tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân/nhỏ so với tuổi thai.
Xem thêm thông tin tại mục "TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA VẮC XIN" và ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC.
Kết quả nghiên cứu trên khả năng sinh sản của động vật với VAXIGRIP TETRA (tổng 60 µg HA/liều) có thể ngoại suy cho VAXIGRIP (tổng 45 µg HA/liều): nghiên cứu này cho thấy không có tác động có hại trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá trình mang thai, sự phát triển của phôi thai hoặc sự phát triển sớm sau khi sinh.

Phụ nữ cho con bú:
Có thể dùng VAXIGRIP khi đang cho con bú sữa mẹ.

Khả năng sinh sản:
Không có dữ liệu về khả năng sinh sản. Một nghiên cứu trên động vật với vắc-xin cúm tứ giá VAXIGRIP TETRA cho thấy không có tác dụng gây hại nào ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con cái.

4.7. Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc
Vắc-xin VAXIGRIP không ảnh hưởng hay ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

4.8. Tác dụng không mong muốn
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng vắc-xin.

<u>a. Tóm tắt về hồ sơ an toàn</u>

Hồ sơ an toàn của VAXIGRIP dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng trên xấp xỉ 17.900 đối tượng từ 6 tháng tuổi sử dụng VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA, và giám sát hậu mãi.
Tùy vào tiền sử tiêm chủng và tuổi của đứa trẻ mà liều và số liều tiêm khác nhau (xem thêm phần "Trẻ em" trong mục b. Bảng danh sách các Tác dụng không mong muốn).
Các phản ứng có hại thường gặp trong vòng 3 ngày đầu sau khi tiêm vắc xin và tự khỏi trong 1 đến 3 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Phần lớn các phản ứng trong dự kiến ở mức độ nhẹ đến vừa.
Phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất sau khi tiêm chủng, ở tất cả nhóm dân số, bao gồm cả nhóm trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi là đau tại chỗ tiêm (59,1% ở trẻ em từ 24 đến 35 tháng tuổi, 65,3% ở trẻ em từ 9 đến 17 tuổi, 52,8% ở người lớn, 29,4% in trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi và 25,8% ở người trên 60 tuổi).
Trong nhóm trẻ em dưới 24 tháng tuổi, khó chịu (34,9%) là phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất.
Ở trẻ em từ 24 đến 35 tháng tuổi, khó chịu (26,8%) là phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất.
Các phản ứng bất lợi khác được báo cáo thường xuyên nhất sau tiêm chủng là:

- Ở người lớn: đau đầu (27,8%), đau cơ (23,0%), khó chịu (19,2%),
- Ở người cao tuổi: đau đầu (15,6%), đau cơ (13,9%),
- Trẻ em từ 9 tuổi đến 17 tuổi: đau cơ (29,1%), đau đầu (28,6%), khó chịu (20,3%), run rẩy (13,0%), ban đỏ tại chỗ tiêm (11,7%) và sưng tại chỗ tiêm (11,4%).
- Ở trẻ em từ 3 đến 8 tuổi: khó chịu (30,7%), ban đỏ tại chỗ tiêm (30,3%), đau cơ (28,5%), đau đầu (25,7%), sưng tại chỗ tiêm (22,1%), khó chịu tại chỗ tiêm (17,6%) và run rẩy (11,2%),
- Ở trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi: sốt (20,4%) và ban đỏ tại chỗ tiêm (17,2%),
    - Trong nhóm trẻ em dưới 24 tháng tuổi: khó chịu (34,9%), khóc bất thường (31,9%), chán ăn (28,9%), buồn ngủ (19,2%) và nôn mửa (17,0%).
    - Trong nhóm trẻ em từ 24 đến 35 tháng tuổi: đau cơ (14,5%), đau đầu (11,9%).

Nhìn chung, các phản ứng bất lợi thường ít gặp hơn ở người cao tuổi so với người lớn và trẻ em.

b. Bảng danh sách các tác dụng không mong muốn

Các dữ liệu sau đây tóm tắt theo tần suất các tác dụng không mong muốn được ghi nhận sau khi chủng ngừa với VAXIGRIP và/hoặc VAXIGRIP TETRA trong các thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình lưu hành sản phẩm trên toàn cầu.
Các tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tần suất theo các qui ước:

Rất thường gặp	(≥ 1/10)
Thường gặp	(≥ 1/100 đến < 1/10)
Không thường gặp	(≥ 1/1.000 đến < 1/100)
Hiếm gặp	(≥ 1/10.000 đến < 1/1.000)
Rất hiếm gặp	(< 1/10.000)
Không rõ:	(không thể đánh giá từ các dữ liệu hiện có): tác dụng không mong muốn đã được báo cáo sau khi sử dụng VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA thương mại dựa trên báo cáo tự phát. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ các quần thể có quy mô không xác định nên không thể ước tính tần suất của chúng một cách đáng tin cậy.

Người lớn và người cao tuổi

Hồ sơ an toàn trình bày sau đây được dựa trên dữ liệu sau:

- Dữ liệu lâm sàng trên hơn 8.000 người lớn (5,064 người dùng VAXIGRIP, 3,040 người dùng VAXIGRIP TETRA) và hơn 5.800 người cao tuổi trên 60 tuổi (4.468 người dùng VAXIGRIP, 1.392 người dùng VAXIGRIP TETRA).
- Dữ liệu trong quá trình lưu hành sản phẩm trên toàn cầu (*).

Tác dụng không mong muốn	Tần suất
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Sưng hạch [1]	Không thường gặp
Giảm tiểu cầu thoáng qua	Không rõ*
Rối loạn hệ miễn dịch	
Các phản ứng dị ứng: quá mẫn với thuốc [2], viêm da dị ứng[2], mày đay [2, 3], đau vùng hầu họng, hen suyễn [1], viêm mũi dị ứng [2], chảy mũi [1], viêm kết mạc dị ứng [2] , ngứa [4], nóng bừng [5]	Không thường gặp
Các phản ứng dị ứng: ngứa [2, 3], sưng mặt, ban đỏ, phát ban, đỏ bừng [5], kích thích niêm mạc miệng [5], dị cảm vùng miệng [5] , kích thích cổ họng, khó thở [2, 3], hắt hơi, tắc mũi [2], tắc nghẽn đường hô hấp trên [2], xung huyết mắt [2], viêm da dị ứng [2], ngứa toàn thân [2]	Hiếm gặp
Phản ứng dị ứng như nổi ban đỏ, phù mạch, sốc	Không rõ*
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	
Giảm sự ngon miệng	Hiếm gặp
Rối loạn hệ thần kinh	
Đau đầu	Rất thường gặp
Chóng mặt [7], buồn ngủ [7]	Không thường gặp
Giảm cảm nhận xúc giác [2], dị cảm	Hiếm gặp
Đau dọc theo dây thần kinh, co giật, viêm não-tủy, viêm thần kinh, hội chứng Guillain-Barré	Không rõ*
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp bị viêm mạch máu thận thoáng qua	Không rõ*
Rối loạn dạ dày-ruột	
Tiêu chảy, buồn nôn	Không thường gặp
Đau vùng bụng [2], nôn	Hiếm gặp
Rối loạn da và mô dưới da	
Tăng tiết mồ hôi [1]	Không thường gặp
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	
Đau cơ	Rất thường gặp
Đau khớp[1]	Không thường gặp
Các rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau chỗ tiêm, khó chịu [6]	Rất thường gặp

Tác dụng không mong muốn	Tần suất
Sốt [7], run rẩy/rét run, đỏ chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm, sưng/phù nề chỗ tiêm	Thường gặp
Suy nhược [1], mệt mỏi, bầm tại chỗ tiêm, ngứa tại chỗ tiêm, nóng tại chỗ tiêm, khó chịu tại chỗ tiêm	Không thường gặp
Hội chứng giống cúm [2], tróc da tại chỗ tiêm [5], tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm [2]	Hiếm gặp

[1] Hiếm gặp ở người cao tuổi
[2] Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở người lớn
[3] Không rõ ở nhóm người cao tuổi
[4] Hiếm gặp ở người lớn
[5] Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở người cao tuổi
[6] Thường gặp ở người cao tuổi
[7] Không thường gặp ở nhóm người cao tuổi

Trẻ em

Tùy vào lịch sử tiêm chủng, trẻ từ 6 tháng tuổi đến 8 tuổi được tiêm một hoặc hai liều VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA. Trẻ em/ thanh thiếu niên từ 9 tuổi đến 17 tuổi được tiêm 1 liều.
Trẻ em từ 6 tháng tuổi dưới 36 tháng tuổi được tiêm với liều 0,25 ml, và trẻ từ 3 tuổi được tiêm với liều 0,5 ml.
Ở trẻ từ 6 tháng đến 8 tuổi, hồ sơ an toàn tương tự sau mũi tiêm thứ nhất và thứ hai với xu hướng tỷ lệ phản ứng bất lợi thấp hơn sau mũi tiêm thứ hai so với mũi đầu tiên ở trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi.

- *Trẻ em và thanh thiếu niên từ 3 tuổi đến 17 tuổi:*

Hồ sơ an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu sau:
- Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng trên 1247 trẻ từ 3 đến 8 tuổi (363 đối tượng dùng VAXIGRIP, 884 đối tượng dùng VAXIGRIP TETRA) và 725 trẻ em/ thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi (296 đối tượng dùng VAXIGRIP, 429 đối tượng dùng VAXIGRIP TETRA),
- Dữ liệu trong quá trình lưu hành sản phẩm trên toàn cầu (*).

Tác dụng không mong muốn	Tần suất
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Phì đại hạch bạch huyết [1]	Không thường gặp
Giảm tiểu cầu [1]	Không thường gặp
Rối loạn hệ miễn dịch	
Các phản ứng dị ứng: nổi mề đay, phát ban, ngứa [1], đau vùng hầu họng [2]	Không thường gặp
Các phản ứng dị ứng: nổi ban đỏ, khó thở, phản ứng phản vệ, phù mạch, sốc	Không rõ*
Rối loạn tâm thần	
Bồn chồn[2], Rên rỉ[2]	Không thường gặp
Rối loạn hệ thần kinh	
Đau đầu	Rất thường gặp

Tác dụng không mong muốn	Tần suất
Chóng mặt	Không thường gặp
Đau dọc theo dây thần kinh, dị cảm, co giật, viêm não-tủy, viêm dây thần kinh và hội chứng Guillain Barré	Không rõ*
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp ảnh hưởng đến thận thoáng qua	Không rõ*
Rối loạn dạ dày-ruột	
Tiêu chảy, đau vùng bụng (2), nôn (2)	Không thường gặp
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	
Đau cơ	Rất thường gặp
Đau khớp (2)	Không thường gặp
Các rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau tại chỗ tiêm, đỏ chỗ tiêm, sưng/phù nề chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm (3), khó chịu, run rẩy/ rét run	Rất thường gặp
Sốt, bầm tại chỗ tiêm	Thường gặp
Ngứa chỗ tiêm, nóng tại vị trí tiêm, khó chịu tại chỗ tiêm (4), khóc (2), suy nhược (4), mệt mỏi	Không thường gặp

(1) Không rõ ở trẻ em/ thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi
(2) Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em từ 3 đến 8 tuổi
(3) Thường gặp ở trẻ em/ thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi
(4) Được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em/ thanh thiếu niên từ 9 đến 17 tuổi

- *Trẻ em từ 06 tháng đến dưới 36 tháng tuổi*

Hồ sơ an toàn trình bày dưới đây dựa trên dữ liệu sau:

- Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng trên 1981 trẻ từ 06 tháng đến 35 tháng tuổi (367 đối tượng dùng VAXIGRIP, 1614 đối tượng dùng VAXIGRIP TETRA).
- Dữ liệu trong quá trình lưu hành sản phẩm trên toàn cầu (*).

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Giảm tiểu cầu, phì đại hạch bạch huyết	Không rõ*
Rối loạn hệ miễn dịch	
Quá mẫn	Không thường gặp
Các phản ứng dị ứng: ngứa toàn thân, nổi mẩn	Hiếm gặp
Các phản ứng dị ứng: ngứa, phát ban đỏ, mày đay, khó thở, phản ứng phản vệ, phù mạch, sốc	Không rõ*
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	
Giảm sự thèm ăn (1)	Rất thường gặp
Rối loạn tâm thần	
Quấy khóc bất thường (2), cáu kỉnh (1)	Rất thường gặp
Rối loạn hệ thần kinh	

Tác dụng không mong muốn	Tần số
Đau đầu [2], ngủ gà/ buồn ngủ [2]	Rất thường gặp
Dị cảm, co giật, viêm não-tủy	Không rõ*
Rối loạn mạch máu	
Viêm mạch máu như ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một vài trường hợp ảnh hưởng đến thận thoáng qua	Không rõ*
Rối loạn dạ dày – ruột	
Nôn [4]	Rất thường gặp
Tiêu chảy	Thường gặp
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	
Đau cơ [5]	Rất thường gặp
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi tiêm	
Đau/nhạy chỗ tiêm, đỏ chỗ tiêm, sốt, khó chịu[5]	Rất thường gặp
Run rẩy/ rét run [3], sưng/ phù nề chỗ tiêm, cứng chỗ tiêm, thâm tím chỗ tiêm	Thường gặp
Các triệu chứng giống cúm, ngứa tại chỗ tiêm, phát ban tại chỗ tiêm	Hiếm gặp

[1] Hiếm gặp ở trẻ từ 24 đến 35 tháng tuổi

[2] Đã báo cáo trên trẻ em từ 06 đến 23 tháng tuổi.

[3] Đã báo cáo trên trẻ em từ 24 đến 35 tháng tuổi.

[4] Không thường gặp ở trẻ từ 24 đến 35 tháng tuổi

[5] Hiếm gặp ở trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi

c. Các nhóm đối tượng khác

Mặc dù chỉ thu tuyển một số lượng hạn chế những người có cùng tình hình bệnh tật, các nghiên cứu được thực hiện ở những người ghép thận, người bị hen suyễn cho thấy không có sự khác biệt lớn về phương diện độ an toàn của VAXIGRIP trên các quần thể này. Hồ sơ an toàn của VAXIGRIP TETRA trên một số nhỏ đối tượng có cùng tình hình bệnh tật tham gia vào các nghiên cứu lâm sàng có kết quả quan sát không khác so với dân số chung.

- *Phụ nữ mang thai*

Trong các nghiên cứu lâm sàng được tiến hành ở phụ nữ mang thai ở Nam Phi và Mali với VAXIGRIP (xem mục "SỬ DỤNG VẮC-XIN CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ" và "ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC"), tần suất các phản ứng tại chỗ và toàn thân trong dự kiến được báo cáo trong vòng 7 ngày sau khi tiêm vắc-xin, tương tự với tần suất được báo cáo cho dân số trưởng thành trong các nghiên cứu lâm sàng. Trong nghiên cứu được thực hiện ở Nam Phi, các phản ứng tại chỗ thường xuyên hơn ở nhóm VAXIGRIP so với nhóm giả dược ở cả nhóm âm tính và dương tính với HIV. Không có sự khác biệt đáng kể trong các phản ứng trong dự kiến giữa nhóm VAXIGRIP và giả dược trong cả hai nhóm.

Trong một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở phụ nữ mang thai ở Phần Lan với VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA (xem mục "SỬ DỤNG VẮC-XIN CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ" và "ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC"), tần suất của các phản ứng tại chỗ và toàn thân trong dự

kiến được báo cáo tương tự với tần suất được báo cáo cho dân số trưởng thành không mang thai trong các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện với VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA, mặc dù cao hơn đối với một số phản ứng bất lợi (đau tại chỗ tiêm, ban đỏ tại chỗ tiêm, khó chịu, run rẩy/ rét run, đau đầu, đau cơ).

Báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ

Việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ sau khi vắc-xin được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm vắc-xin. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi đáng ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng bất lợi của thuốc theo địa chỉ email: di.pvcenter@gmail.com

4.9. Quá liều

Các trường hợp sử dụng quá liều khuyến cáo đã được báo cáo đối với VAXIGRIP. Báo cáo về tác dụng không mong muốn trong các trường hợp sử dụng quá liều phù hợp với thông tin về độ an toàn của VAXIGRIP trình bày trong mục "TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN".

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

5. Các đặc tính dược lý

5.1. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý điều trị: Vắc-xin Cúm

Mã ATC: J07BB02

Cơ chế tác động

Vắc-xin VAXIGRIP cung cấp miễn dịch chủ động chống lại ba chủng virus Cúm (hai chủng virus cúm A và một chủng virus cúm B) có trong vắc-xin.

Đáp ứng miễn dịch kháng thể được hình thành dần trong 2-3 tuần. Các kháng thể này giúp trung hòa virus cúm.

Mức đo hiệu giá kháng thể haemaglutinin-inhibition (HAI) sau tiêm chủng được sử dụng làm thước đo hoạt tính của vắc-xin và không tương quan với việc bảo vệ khỏi bệnh cúm. Trong một số nghiên cứu ở người cho thấy hiệu giá kháng thể haemaglutinin-inhibition (HAI) > 1:40 liên quan đến việc bảo vệ bệnh cúm trên 50% đối tượng.

Do virus cúm không ngừng biến đổi nên các chủng virus của vắc-xin cúm được W.H.O. xem xét và chọn lựa hàng năm.

Nên thực hiện tiêm vắc-xin phòng cúm hàng năm dựa trên thời gian miễn dịch do vắc-xin cung cấp và do các chủng vi-rút cúm lưu hành thay đổi theo từng năm.

Hiệu lực

Dữ liệu hiệu quả của VAXIGRIP có sẵn ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi sinh ra từ người mẹ được tiêm chủng (bảo vệ thụ động).

Ở trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi và từ 3 đến 8 tuổi (tiêm chủng chủ động), hiệu lực của VAXIGRIP dựa trên ngoại suy kết quả của VAXIGRIP TETRA.

Hiện không có dữ liệu về hiệu lực của VAXIGRIP ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 tháng đến 17 tuổi, ở người lớn và người cao tuổi.

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi sinh ra từ người mẹ được chủng ngừa trong thai kỳ (bảo vệ thụ động)

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ mắc cúm cao, dẫn đến tỷ lệ nhập viện cao; tuy nhiên, vắc-xin cúm không được chỉ định sử dụng ở nhóm tuổi này.

Hiệu lực trên trẻ sơ sinh được sinh ra những phụ nữ đã tiêm một liều 0,5 ml VAXIGRIP trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ đã được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng.

Hiệu lực của VAXIGRIP ở trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc-xin cho phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu chưa được nghiên cứu trong các thử nghiệm này. Tuy nhiên, không nên hoãn tiêm vắc-xin cúm trong ba tháng đầu (xem mục "SỬ DỤNG VẮC-XIN CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ").

Trong các nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng, giai đoạn IV, được thực hiện ở Mali, Nepal và Nam Phi, khoảng 5.000 phụ nữ mang thai đã tiêm VAXIGRIP và khoảng 5.000 phụ nữ mang thai sử dụng giả dược hoặc vắc xin đối chứng (vắc-xin liên hợp não mô cầu tứ giá) trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ. Hiệu lực của vắc-xin trên bệnh cúm được xác định qua xét nghiệm ở phụ nữ mang thai được đánh giá là tiêu chí phụ trong cả ba nghiên cứu.

Các nghiên cứu được thực hiện ở Mali và Nam Phi đã chứng minh hiệu quả của VAXIGRIP trong việc phòng ngừa cúm ở phụ nữ mang thai sau khi tiêm chủng trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ (xem Bảng 1). Trong nghiên cứu được thực hiện ở Nepal, hiệu quả của VAXIGRIP trong việc ngăn ngừa bệnh cúm ở phụ nữ mang thai sau khi tiêm chủng trong giai đoạn này chưa được chứng minh.

Bảng 1: Tỷ lệ nhiễm cúm và hiệu lực của VAXIGRIP phòng chống cúm được xác định qua xét nghiệm ở phụ nữ mang thai

	Tỷ lệ nhiễm cúm (bất kể chủng A hoặc B) % (n/N)		**Hiệu lực của VAXIGRIP % (95% CI)**
	Vắc-xin tam giá	**Nhóm chứng***	
Mali	0,5 (11/2.108)	1,9 (40/2.085)	70,3 (42,2 đến 85,8)
	Vắc-xin tam giá	**Giả dược**	
Nam Phi	1,8 (19/1.062)	3,6 (38/1.054)	50,4 (14,5 to 71,2)

* Vắc-xin não mô cầu

N: Số phụ nữ có thai được đưa vào phân tích

n: Số đối tượng được xác nhận mắc cúm qua xét nghiệm

CI: Khoảng tin cậy

Trong cùng nghiên cứu lâm sàng giai đoạn IV ngẫu nhiên, kiểm soát được tiến hành tại Mali, Nepal và Nam Phi, 4530 trong số 4898 trẻ sơ sinh (92%) có mẹ đã tiêm VAXIGRIP, và 4532 trong số 4868 trẻ sơ sinh (93%) có mẹ sử dụng giả dược hoặc vắc xin đối chứng (vắc-xin liên hợp não mô cầu tứ giá) (xem Bảng 2), trong ba tháng giữa hoặc cuối thai kỳ, đã được theo dõi cho đến khoảng 6 tháng tuổi.

Những nghiên cứu này đã xác nhận hiệu quả của VAXIGRIP trong việc ngăn ngừa cúm ở trẻ sơ sinh từ khi mới sinh đến khoảng 6 tháng tuổi sau khi tiêm vắc-xin cho người mẹ trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ. Phụ nữ trong ba tháng đầu của thai kỳ không được đưa vào các nghiên cứu này; do đó không thể đánh giá hiệu quả của VAXIGRIP ở trẻ sinh ra từ các bà mẹ được tiêm chủng trong ba tháng đầu.

Bảng 2: Tỷ lệ nhiễm cúm và hiệu lực của VAXIGRIP phòng chống bệnh cúm được xác định qua xét nghiệm ở trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc-xin ở phụ nữ mang thai

	Tỷ lệ nhiễm cúm (bất kể chủng A hoặc B) % (n/N)		Hiệu lực của VAXIGRIP % (95% CI)
	Vắc-xin tam giá	**Nhóm chứng***	
Mali	2,4 (45/1.866)	3,8 (71/1.869)	37,3 (7,6 đến 57,8)
	Vắc-xin tam giá	**Giả dược**	
Nepal	4,1 (74/1.820)	5,8 (105/1.826)	30,0 (5 đến 48)
Nam Phi	1,9 (19/1.026)	3,6 (37/1.023)	48,8 (11,6 đến 70,4)

* Vắc-xin não mô cầu
N: Số trẻ sơ sinh được đưa vào phân tích
n: Số đối tượng được xác nhận mắc cúm qua xét nghiệm
CI: Khoảng tin cậy

Dữ liệu hiệu lực cho thấy hiệu quả bảo vệ của vắc-xin trên trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ được tiêm chủng suy yếu dần theo thời gian.

Trong thử nghiệm được thực hiện ở Nam Phi, hiệu lực của vắc-xin cao nhất ở trẻ sơ sinh từ 8 tuần tuổi trở xuống (85,8% [95% CI, 38,3 đến 98,4]) và giảm dần theo thời gian; Hiệu lực của vắc-xin là 25,5% (95% CI, -67,9 đến 67,8) đối với trẻ sơ sinh từ 8 đến 16 tuần tuổi và 30,4% (95% CI, -154,9 đến 82,6) đối với trẻ sơ sinh từ 16 đến 24 tuần tuổi.

Trong thử nghiệm được tiến hành ở Mali, hiệu lực của VAXIGRIP cũng có xu hướng cao hơn ở trẻ sơ sinh trong 4 tháng đầu sau khi sinh (70,2% [95% CI, 35,7 đến 87,6]), hiệu lực thấp hơn trong tháng theo dõi thứ năm và giảm rõ rệt trong tháng thứ sáu.

Việc ngăn ngừa bệnh cúm chỉ có thể được mong đợi nếu trẻ sơ sinh tiếp xúc với các chủng vi-rút có trong vắc xin được tiêm cho mẹ.

Trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi:

Các nghiên cứu ngẫu nhiên trên giả dược đã được tiến hành tại 4 khu vực (Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ la tinh và Châu Âu), trong 4 mùa cúm, trên hơn 5.400 trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi, đã tiêm 2 liều (liều 0,5 ml) vắc-xin VAXIGRIP TETRA (N=2.722) hoặc giả dược (N=2.717) cách nhau 28 ngày, để đánh giá hiệu quả của VAXIGRIP TETRA trong việc ngăn ngừa bệnh bệnh cúm được xác định qua xét nghiệm, gây ra bởi chủng vi-rút A và/hoặc B bất kỳ và bởi các chủng virus tương tự với các thành phần có trong vắc-xin (được xác định bằng phương pháp giải trình tự).

Bệnh cúm được xác định qua xét nghiệm được định nghĩa là bệnh giống cúm (ILI) [xảy ra sốt ≥ 38°C (kéo dài ít nhất 24 giờ) đồng thời với ít nhất một trong các triệu chứng sau: ho, tắc mũi, chảy nước mũi, viêm họng, viêm tai, nôn mửa hoặc tiêu chảy], được xác định bằng RT-PCR (Reverse transcriptase polymerase chain reaction) và/hoặc nuôi cấy vi-rút.

Bảng 3: Tỷ lệ nhiễm cúm và hiệu lực của VAXIGRIP phòng chống bệnh cúm được xác định qua xét nghiệm ở trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi

	Vaxigrip Tetra (N=2.584)		Giả dược (N=2.591)		Hiệu lực
	n	**tỷ lệ nhiễm cúm (%)**	**n**	**tỷ lệ nhiễm cúm (%)**	**% (Khoảng tin cậy 95%, giá trị tới hạn 2**

					đuôi.)
Các nguyên nhân nhiễm cúm trong thử nghiệm lâm sàng:					
- Bất kỳ cúm A hoặc cúm B	122	4,72	255	9,84	52,03 (40,24; 61,66)
- Chủng virus tương tự với các thành phần có trong vắc-xin	26	1,01	85	3,28	69,33 (51,93; 81,03)

N: Số trẻ được đưa vào phân tích (toàn bộ)
n: số đối tượng hoàn tất hạng mục được liệt kê
Cl: Khoảng tin cậy (Confidence Interval)

Ngoài ra, một nghiên cứu bổ sung được xác định cho thấy vắc-xin VAXIGRIP TETRA ngăn ngừa 56,6% (95% Cl: 37,0; 70,5) các bệnh cúm nặng được xác định trong phòng thí nghiệm gây ra do bất kỳ chủng nào và 71,7% (95% CI: 43,7; 86,9) bệnh cúm nặng gây ra bởi các chủng tương tự. Bên cạnh đó, 59,2% các đối tượng sử dụng vắc-xin VAXIGRIP TETRA (95% CI: 44,4; 70,4) ít có khả năng nhiễm bệnh cúm hơn so với đối tượng sử dụng giả dược.

Nhiễm cúm nặng được định nghĩa là bệnh giống cúm được xác định bằng RT-PCR và/hoặc nuôi cấy virus có tối thiểu một trong các triệu chứng dưới đây:

- Sốt > 39,5° C trên đối tượng trẻ em < 24 tháng hoặc sốt ≥ 39,0° C ở trẻ em ≥ 24 tháng,
- Và/ hoặc ít nhất một triệu chứng ILI nghiêm trọng gây ảnh hưởng các hoạt động hằng ngày (ho, nghẹt mũi, chảy mũi, viêm họng, viêm tai giữa, nôn mửa, tiêu chảy),
- Và/ hoặc một trong các trường hợp sau: viêm tai giữa cấp tính, nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp dưới (viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm thanh quản), nhập viện nội trú.

Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi:

Dựa trên quan sát đáp ứng miễn dịch ở trẻ từ 3 đến 8 tuổi cho thấy tính hiệu lực của vắc-xin VAXIGRIP TETRA tương tự với quần thể trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi (xem dữ liệu phần "Trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi" và "Tính sinh miễn dịch của vắc-xin VAXIGRIP TETRA").

Tính sinh miễn dịch của vắc-xin VAXIGRIP TETRA

Các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở người lớn từ 18 đến 60 tuổi, người cao tuổi > 60 tuổi, trẻ em từ 3 đến 8 tuổi và trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi mô tả tính đáp ứng miễn dịch của VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA đối với hiệu giá kháng thể trung bình HAI (GMT) ở ngày Thứ 21 (người lớn) và ngày Thứ 28 (trẻ em), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh HAI (tăng gấp 4 lần so với trị số nghịch đảo hoặc thay đổi từ mức không xác định được [<10] đến mức nghịch đảo là [≥40] và hiệu giá kháng thể trung bình HAI (trước và sau tiêm chủng).

Một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trên người lớn từ 18 đến 60 tuổi và trên trẻ em từ 9 đến 17 tuổi mô tả tính đáp ứng miễn dịch của vắc-xin VAXIGRIP và VAXIGRIP TETRA đối với hiệu giá kháng thể trung bình HAI ở ngày Thứ 21. Một nghiên cứu lâm sàng khác được thực hiện ở trẻ em từ 9 đến 17 tuổi chỉ mô tả đáp ứng miễn dịch của vắc-xin VAXIGRIP TETRA.

Một nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trên phụ nữ mang thai mô tả đáp ứng miễn dịch của VAXIGRIP TETRA và VAXIGRIP đối với hiệu giá kháng thể trung bình HAI vào Ngày 21, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh và hiệu giá kháng thể trung bình HAI (trước và sau tiêm chủng) sau một liều dùng trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ. Trong nghiên cứu này, sự chuyển đổi qua nhau thai được đánh giá bằng hiệu giá kháng thể trung bình HAI trong máu người mẹ, máu cuống rốn và tỷ lệ máu cuống rốn/máu mẹ, khi sinh.

VAXIGRIP gây ra đáp ứng miễn dịch đáng kể trên 3 chủng cúm có trong vắc-xin.
Ở trẻ em từ 3 tuổi, ở người lớn bao gồm cả phụ nữ mang thai và người cao tuổi, VAXIGRIP có tính sinh miễn dịch như VAXIGRIP TETRA đối với các chủng phổ biến.

Người lớn và người cao tuổi

Trong một nghiên cứu lâm sàng, người lớn từ 18 đến 60 tuổi và người cao tuổi trên 60 tuổi được đánh giá tính đáp ứng miễn dịch sau 1 liều tiêm chủng 0,5 ml vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA.
Kết quả về tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI ở người lớn từ 18 đến 60 tuổi và ở người cao tuổi trên 60 tuổi được trình bày lần lượt trong Bảng 4 và Bảng 5.

Bảng 4: Tính sinh miễn dịch ở người lớn từ 18 đến 60 tuổi, 21 ngày sau khi tiêm vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá thay thế [a] (B Victoria) N = 140	Vắc-xin tam giá cấp phép [b] (B Yamagata) N = 138	Vắc-xin tứ giá N=832
	GMT (95% CI)		
A (H1N1) [c][d]	685 (587; 800)		608 (563;657)
A (H3N2) [c]	629 (543; 728)		498 (459; 541)
B (Victoria)	735 (615; 879)	-	708 (661; 760)
B (Yamagata)	-	1735 (1490; 2019)	1715 (1607; 1830)
	SC % (95% CI) [e]		
A (H1N1) [c][d]	65,1 (59,2; 70,7)		64,1 (60,7; 67,4)
A (H3N2) [c]	73,4 (67,8; 78,5)		66,2 (62,9; 69,4)
B (Victoria)	70,0 (61,7; 77,4)	-	70,9 (67,7; 74,0)
B (Yamagata)	-	60,9 (52,2; 69,1)	63,7 (60,3;67,0)
	GMTR (95% CI) [f]		
A (H1N1) [c][d]	10,3 (8,35; 12,7)		9,77 (8,69; 11,0)
A (H3N2) [c]	14,9 (12,1; 18,4)		10,3 (9,15; 11,5)
B (Victoria)	11,4 (8,66; 15,0)	-	11,6 (10,4; 12,9)
B (Yamagata)	-	6,08 (4,79; 7,72)	7,35 (6,66;8,12)

N: số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét
GMT: Hiệu giá kháng thể trung bình (Geometric Mean Titer); Cl: Khoảng tin cậy (Confidence interval)

(a) Vắc-xin tam giá thay thế chứa A / California / 7/2009 (H1N1), A / Texas / 50/2012 (H3N2) và B / Brisbane / 60/2008 (dòng Victoria)

(b) Vắc-xin tam giá cấp phép 2014-2015 có chứa A / California / 7 / 2009 (H1N1), A / Texas / 50/2012 (H3N2) và B / Massachusetts / 2/2012 (dòng Yamagata)

(c) Nhóm vắc-xin tam giá gộp bao gồm những người tham gia được tiêm vắc-xin tam giá thay thế hoặc vắc-xin tam giá cấp phép, N = 278

(d) N = 833 cho nhóm vắc-xin tứ giá

(e) SC: tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh: cho đối tượng trước tiêm chủng < 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của đối tượng sau tiêm chủng ≥ 40 (1/dil) so với trước tiêm chủng ≥ 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng (so với trước tiêm chủng).

(f) GMTR: Hiệu giá kháng thể trung bình (trước và sau tiêm chủng)

Bảng 5: Tính sinh miễn dịch ở người cao tuổi trên 60 tuổi, 21 ngày sau khi tiêm vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá thay thế [a] (B Victoria) N = 138	Vắc-xin tam giá cấp phép [b] (B Yamagata) N = 137	Vắc-xin tứ giá N=831
	GMT (95% CI)		
A (H1N1) [c] [d]	268 (228; 314)		219 (199; 241)
A (H3N2) [c]	410 (352; 476)		359 (329; 391)
B (Victoria)	301 (244; 372)	-	287 (265; 311)
B (Yamagata)	-	697 (593; 820)	655 (611; 701)
	SC % (95% CI) [e]		
A (H1N1) [c] [d]	50.2 (44.1; 56.2)		45.6 (42.1; 49.0)
A (H3N2) [c]	48.5 (42.5; 54.6)		47.5 (44.1; 51.0)
B (Victoria)	43.5 (35.1; 52.2)	-	45.2 (41.8; 48.7)
B (Yamagata)	-	38.7 (30.5; 47.4)	42.7 (39.3; 46.2)
	GMTR (95% CI) [f]		
A (H1N1) [c] [d]	6.03 (4.93; 7.37)		4.94 (4.46; 5.47)
A (H3N2) [c]	5.79 (4.74; 7.06)		5.60 (5.02; 6.24)
B (Victoria)	4.60 (3.50; 6.05)	-	4.61 (4.18; 5.09)
B (Yamagata)	-	4.11 (3.19; 5.30)	4.11 (3.73; 4.52)

N: số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét

GMT: Hiệu giá kháng thể trung bình (Geometric Mean Titer); Cl: Khoảng tin cậy (Confidence interval)

(a) Vắc-xin tam giá thay thế chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2), và B/Brisbane/60/2008 (dòng Victoria)

(b) Vắc-xin tam giá cấp phép 2014-2015 có chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) và B/Massachusetts/2/2012 (dòng Yamagata)

(c) Nhóm vắc-xin tam giá gộp bao gồm những người tham gia được tiêm vắc-xin tam giá thay thế hoặc vắc-xin tam giá cấp phép, N = 275

(d) N = 832 cho nhóm vắc-xin tứ giá

(e) SC: tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh: cho đối tượng trước tiêm chủng < 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của đối tượng sau tiêm chủng ≥ 40 (1/dil) so với trước tiêm chủng ≥ 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng (so với trước tiêm chủng).

(f) GMTR: Hiệu giá kháng thể trung bình (trước và sau tiêm chủng)

Phụ nữ mang thai và chuyển nhau thai

Trong một nghiên cứu lâm sàng, tổng cộng có 116 phụ nữ mang thai đã dùng VAXIGRIP và 230 phụ nữ mang thai đã dùng VAXIGRIP TETRA trong ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối của thai kỳ (từ tuần 20 đến 32 của thai kỳ).

Kết quả Tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI, ở phụ nữ mang thai 21 ngày sau khi tiêm vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6: Tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI ở phụ nữ mang thai, 21 ngày sau khi tiêm vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá (B Victoria) N = 109	Vắc-xin tứ giá N=216

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá (B Victoria) N = 109	Vắc-xin tứ giá N=216
	GMT (95% CI)	
A (H1N1)*	638 (529; 769)	525 (466; 592)
A (H3N2)*	369 (283; 483)	341 (286; 407)
B1 (Victoria)*	697 (569; 855)	568 (496; 651)
B 2 (Yamagata)*	-	993 (870; 1134)
	tăng ≥4 lần n (%) [(a)]	
A (H1N1)*	41,3 (31,9; 51,1)	38,0 (31,5; 44,8)
A (H3N2)*	62,4 (52,6; 71,5)	59,3 (52,4; 65,9)
B1 (Victoria)*	60,6 (50,7; 69,8)	61,1 (54,3; 67,7)
B 2 (Yamagata)*	-	59,7 (52,9; 66,3)
	GMTR (95% CI) [(b)]	
A (H1N1)*	5,26 (3,66; 7,55)	3,81 (3,11; 4,66)
A (H3N2)*	9,23 (6,56; 13,0)	8,63 (6,85; 10,9)
B 1 (Victoria)*	9,62 (6,89; 13,4)	8,48 (6,81; 10,6)
B 2 (Yamagata)*	-	6,26 (5,12; 7,65)

N: số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét

GMT: Hiệu giá kháng thể trung bình (Geometric Mean Titer); Cl: Khoảng tin cậy (Confidence interval)

* A/H1N1: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus; A/H3N2: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)- like virus; B1: B/Brisbane/60/2008-like virus (dòng B/Victoria): *chủng này có trong trong thành phần vắc-xin tam giá;* B2: B/Phuket/3073/2013-like virus (dòng B/Yamagata): *chủng này không có trong trong thành phần vắc-xin tam giá.*

(a) SC: tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh: cho đối tượng trước tiêm chủng < 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của đối tượng sau tiêm chủng ≥ 40 (1/dil) so với trước tiêm chủng ≥ 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng (so với trước tiêm chủng).

(b) GMTR: Hiệu giá kháng thể trung bình (trước và sau tiêm chủng)

Đánh giá mô tả tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI khi sinh, trong mẫu máu của người mẹ (BL03M), trong mẫu máu cuống rốn (BL03B) và chuyển nhau thai (BL03B / BL03M) được trình bày trong bảng 7.

Bảng 7: Đánh giá mô tả tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI của VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA khi sinh

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá (B Victoria) N = 89	Vắc-xin tứ giá N = 178
	BL03M (máu người mẹ) GMT (95% CI)	
A (H1N1)*	411 (332; 507)	304 (265; 349)
A (H3N2)*	186 (137; 250)	178 (146; 218)
B1 (Victoria)*	371 (299; 461)	290 (247; 341)
B 2 (Yamagata)*	-	547 (463; 646)
	BL03B (máu cuống rốn) GMT (95% CI)	
A (H1N1)*	751 (605; 932)	576 (492; 675)

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá (B Victoria) N = 89	Vắc-xin tứ giá N = 178
A (H3N2)*	324 (232; 452)	305 (246; 379)
B1 (Victoria)*	608 (479; 772)	444 (372; 530)
B 2 (Yamagata)*	-	921 (772; 1099)
	Chuyển nhau thai: BL03B/BL03M ** GMT (CI 95%)	
A (H1N1)*	1,83 (1,64; 2,04)	1,89 (1,72; 2,08)
A (H3N2)*	1,75 (1,55; 1,97)	1,71 (1,56; 1,87)
B 1 (Victoria)*	1,64 (1,46; 1,85)	1,53 (1,37; 1,71)
B 2 (Yamagata)*	-	1,69 (1,54; 1,85)

N: số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét: phụ nữ đã tiêm vắc xin cúm tam giá hoặc tứ giá, đã chuyển dạ ít nhất 2 tuần sau khi tiêm và có sẵn máu cuống rốn và máu của người mẹ tại thời điểm sinh.
GMT: Hiệu giá kháng thể trung bình (Geometric Mean Titer); Cl: Khoảng tin cậy (Confidence interval)

* A/H1N1: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus; A/H3N2: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) -like virus;
B1: B/Brisbane/60/2008-like virus (dòng B/Victoria): chủng này được đưa vào thành phần vắc-xin tam giá;
B2: B/Phuket/3073/2013-like virus (dòng B/Yamagata): chủng này không có trong trong thành phần vắc-xin tam giá.
†BL03M: Mẫu máu của người mẹ khi sinh
**BL03B: Mẫu máu cuống rốn khi sinh
§ Nếu một người mẹ có X đứa con, giá trị ngưỡng của cô ấy được tính X lần

Khi sinh, mức độ kháng thể trong mẫu máu cuống rốn cao hơn so với mẫu máu của người mẹ, gợi ý rằng có sự chuyển kháng thể qua nhau thai từ mẹ sang trẻ sơ sinh sau khi tiêm ngừa cho người mẹ bằng VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ.

Những dữ liệu này phù hợp với sự bảo vệ thụ động được chứng minh ở trẻ sơ sinh từ lúc mới sinh đến khoảng 6 tháng tuổi sau khi tiêm vắc-xin cho phụ nữ trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ bằng VAXIGRIP trong các nghiên cứu được thực hiện ở Mali, Nepal và Nam Phi (xem phần "Hiệu lực").

Trẻ em

- Trẻ em từ 9 đến 17 tuổi:

Trong tổng số 55 trẻ em từ 9 đến 17 tuổi được tiêm một liều VAXIGRIP và 429 trẻ được tiêm một liều VAXIGRIP TETRA, đáp ứng miễn dịch chống lại các chủng có trong vắc-xin tương tự như đáp ứng miễn dịch gây ra ở người lớn từ 18 đến 60 tuổi.

- Trẻ từ 3 đến 8 tuổi:

Trong một nghiên cứu lâm sàng, đáp ứng miễn dịch được mô tả ở trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được tiêm một hoặc hai liều VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA 0,5 ml, tùy thuộc vào tiền sử tiêm chủng cúm trước đó của trẻ.

Những trẻ được tiêm một hoặc hai liều vắc-xin VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA có biểu hiện đáp ứng miễn dịch tương đương với liều cuối cùng của lịch chủng ngừa tương ứng.

Kết quả Tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI, 28 ngày sau khi tiêm mũi cuối cùng được trình bày trong Bảng 8.

Bảng 8: Tính sinh miễn dịch ở trẻ em từ 3 đến 8 tuổi, 28 ngày sau lần tiêm cuối cùng

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá thay thế [a] (B Victoria) N = 176	Vắc-xin tam giá cấp phép [b] (B Yamagata) N = 168	Vắc-xin tứ giá N = 863
	GMT (95% CI)		
A (H1N1) [c]	1141 (1006; 1295)		971 (896; 1052)
A (H3N2) [c]	1746 (1551; 1964)		1568 (1451; 1695)
B (Victoria) [d]	1120 (921; 1361)	-	1050 (956; 1154)
B (Yamagata) [e] [f]	-	1211 (1003; 1462)	1173 (1078; 1276)
	SC% (95% CI) [g]		
A (H1N1) [c]	65,7 (60,4; 70,7)		65,7 (62,4; 68,9)
A (H3N2) [c]	67,7 (62,5; 72,6)		64,8 (61,5; 68,0)
B (Victoria) [d]	90,3 (85,0; 94,3)	-	84,8 (82,3; 87,2)
B (Yamagata) [e] [f]	-	89,9 (84,3; 94,0)	88,5 (86,2; 90,6)
	GMTR (95% CI) [h]		
A (H1N1) [c]	7,65 (6,54; 8,95)		6,86 (6,24; 7,53)
A (H3N2) [c]	7,61 (6,69; 9,05)		7,49 (6,72; 8,35)
B (Victoria) [d]	17,8 (14,5; 22,0)	-	17,1 (15,5; 18,8)
B (Yamagata) [e] [f]	-	30,4 (23,8; 38,4)	25,3 (22,8; 28,2)

N = số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét

GMT: Hiệu giá trung bình nhân; CI: Khoảng tin cậy

(a) Vắc-xin tam giá thay thế chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2), và B/Brisbane/60/2008 (dòng Victoria)

(b) Vắc-xin tam giá cấp phép 2014-2015 có chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) và B/Massachusetts/2/2012 (dòng Yamagata)

(c) Nhóm vắc-xin tam giá gộp bao gồm những người tham gia được tiêm vắc-xin tam giá thay thế hoặc vắc-xin tam giá cấp phép, N = 344

(d) N=169 cho nhóm vắc-xin tam giá (B Yamagata)

(e) N = 862 cho nhóm vắc-xin tứ giá

(f) N=175 cho nhóm Vaxigrip (B Victoria)

(g) SC: tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh: cho đối tượng trước tiêm chủng < 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của đối tượng sau tiêm chủng ≥ 40 (1/dil) so với trước tiêm chủng ≥ 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng (so với trước tiêm chủng).

(h) GMTR: Hiệu giá kháng thể trung bình (trước và sau tiêm chủng)

- Trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi:

Trong một nghiên cứu lâm sàng, đáp ứng miễn dịch được mô tả ở trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được tiêm một hoặc hai liều VAXIGRIP hoặc VAXIGRIP TETRA 0,5 ml.

Kết quả Tính sinh miễn dịch bằng phương pháp HAI, 28 ngày sau khi tiêm mũi cuối cùng được trình bày trong Bảng 9.

Bảng 9: Tính sinh miễn dịch ở trẻ em từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi, 28 ngày sau lần tiêm cuối cùng

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá thay thế [a] (B Victoria) N = 172	TIV được cấp phép [b] [c] (B Yamagata) N = 178	Vắc-xin tứ giá N = 341

Chủng kháng nguyên	Vắc-xin tam giá thay thế [a] (B Victoria) N = 172	TIV được cấp phép [b] [c] (B Yamagata) N = 178	Vắc-xin tứ giá N = 341
	GMT (95% CI)		
A (H1N1)	637 (500; 812)	628 (504; 781)	641 (547; 752)
A (H3N2)	1021 (824; 1266)	994 (807; 1224)	1071 (925; 1241)
B (Victoria)	835 (691; 1008)	-	623 (550; 706)
B (Yamagata) [d]	-	1009 (850; 1198)	1010 (885; 1153)
	SC % (95% CI) [e]		
A (H1N1)	87,2 (81,3; 91,8)	90,4 (85,1; 94,3)	90,3 (86,7; 93,2)
A (H3N2)	88,4 (82,6; 92,8)	87,6 (81,9; 92,1)	90,3 (86,7; 93,2)
B (Victoria)	99,4 (96,8; 100,0)	-	98,8 (97,0; 99,7)
B (Yamagata)	-	99,4 (96,9; 100,0)	96,8 (94,3; 98,4)
	GMTR (95% CI) [f]		
A (H1N1)	35,3 (27,4; 45,5)	40,6 (32,6; 50,5)	36,6 (30,8; 43,6)
A (H3N2)	44,1 (33,1; 58,7)	37,1 (28,3; 48,6)	42,6 (35,1; 51,7)
B (Victoria)	114 (94,4; 138)	-	100 (88,9; 114)
B (Yamagata)	-	111 (91,3; 135)	93,9 (79,5; 111)

N = số đối tượng có dữ liệu sẵn có cho tiêu chí đánh giá được xem xét

GMT: Hiệu giá trung bình nhân; CI: Khoảng tin cậy

(a) Vaxigrip thay thế chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) và B/Brisbane/60/2008 (dòng Victoria)

(b) Vaxigrip cấp phép 2014-2015 có chứa A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) và B/Massachusetts/2/2012 (dòng Yamagata)

(c) Liều 0,5 ml

(d) N = 171 cho nhóm Vaxigrip Thay thế (B Victoria)

(e) SC: tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh: cho đối tượng trước tiêm chủng < 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của đối tượng sau tiêm chủng ≥ 40 (1/dil) so với trước tiêm chủng ≥ 10 (1/dil), tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng (so với trước tiêm chủng).

(f) GMTR: Hiệu giá kháng thể trung bình (trước và sau tiêm chủng)

Những dữ liệu sinh miễn dịch này cung cấp thông tin hỗ trợ bên cạnh các dữ liệu về hiệu quả của vắc-xin có sẵn trong nhóm dân số (xem phần "Hiệu lực").

5.2. Đặc tính dược động học

Không áp dụng.

5.3. Số liệu an toàn tiền lâm sàng

Dữ liệu trên động vật thu thập từ VAXIGRIP TETRA (tổng 60 µg ha/liều) có thể ngoại suy cho VAXIGRIP (tổng 45 HA/liều): những dữ liệu này cho thấy không có phát hiện ngoài dự kiến và không gây độc hại trên cơ quan đích.

Các dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có nguy cơ gây hại đặc biệt nào trên người dựa trên các nghiên cứu thông thường về liều nhắc và độc tính tại chỗ, độc tính sinh sản và phát triển, và các nghiên cứu dược lý an toàn.

6. Các đặc tính dược học

6.1. Danh mục tá dược

Dung dịch đệm

Thành phần dung dịch đệm (PBS): Natri chloride, Kali chloride, Dinatri phosphate dihydrate, Kali dihydrogen phosphate, Nước pha tiêm.

Vắc-xin VAXIGRIP có thể chứa một lượng rất nhỏ (vết) của trứng như ovalbumin và neomycin, formaldehyde, và octoxinol-9, những chất được sử dụng trong quá trình sản xuất.

6.2. Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của vắc-xin, không trộn lẫn vắc-xin này với các vắc-xin hoặc thuốc khác.

6.3. Tuổi thọ

12 tháng kể từ ngày sản xuất.

6.4. Cảnh báo đặc biệt về bảo quản

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

Bảo quản trong tủ lạnh (+2ºC đến +8ºC). Không được để đông băng.

Đặt bơm tiêm chứa vắc-xin trong hộp giấy để tránh ánh sáng.

6.5. Tính chất và dung lượng của bao bì đóng gói

Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5 ml vắc-xin.

7. Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành sản phẩm

CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM

Phòng 14.01 – Tầng 14 và Tầng 15, Tháp 2, Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8. Số đăng ký lưu hành sản phẩm

…

9. Ngày cấp số đăng ký lưu hành lần đầu/gia hạn số đăng ký

…

10. Ngày xem xét lại bản tóm tắt đặc tính sản phẩm

…